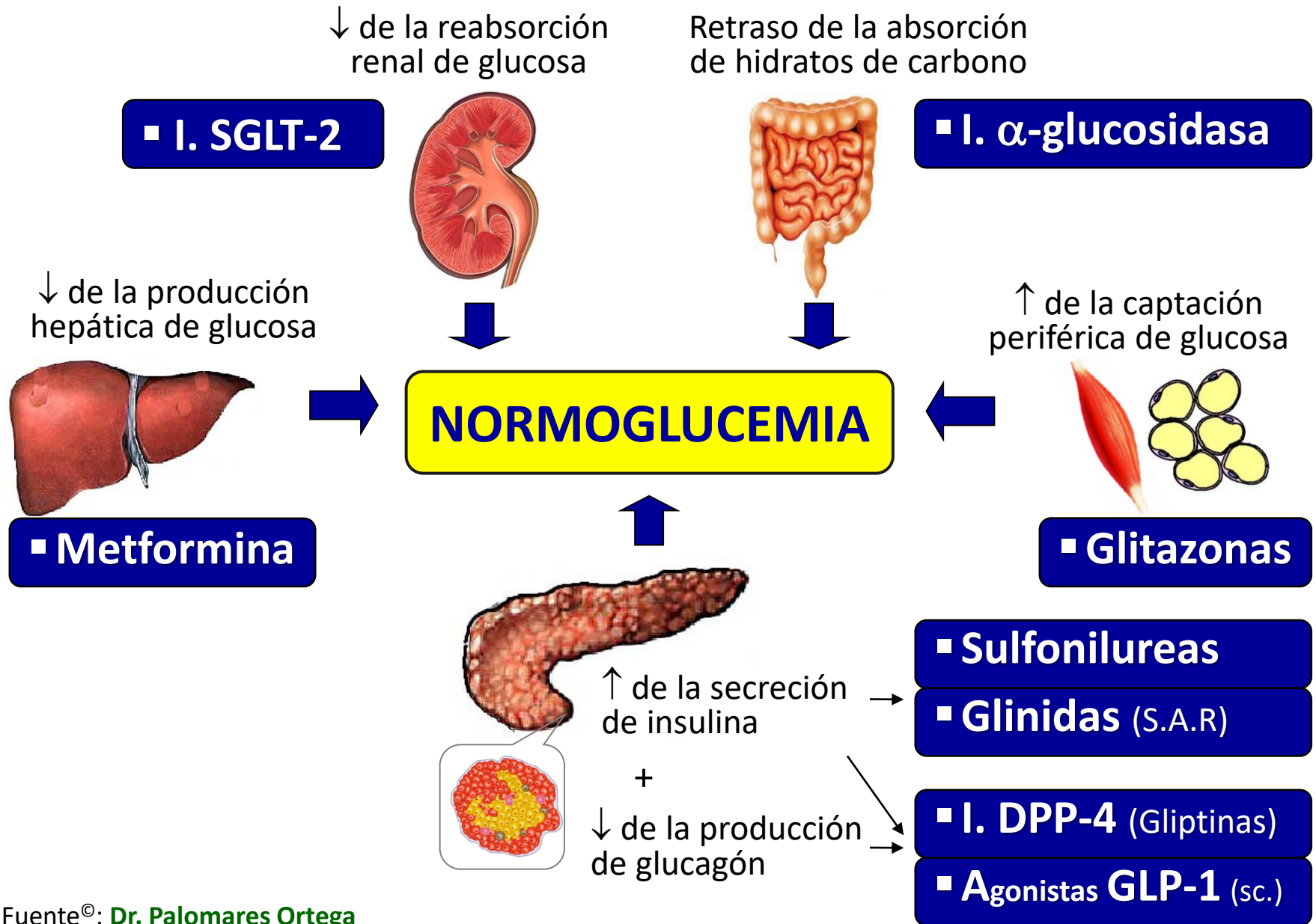


ANTIDIABÉTICOS ORALES (2021-A)©



► REGULADORES DE LA SECRECIÓN DE INSULINA (y glucagón#):

- **Sulfonilureas:** · Glimepirida 2 y 4 mg (*Amaryl. Roname*®) · Glipizida 5 mg (*Minodiab*®) · Gliclazida 30 y 60 (*Diamicron*®)
- **Glinidas (Secretagogos de Acción Rápida):** · Repaglinida 0.5, 1 y 2 mg (*Novonorm. Prandin*®)
· Nateglinida 60, 120 y 180 mg (*Starlix*®)
- **Inhibidores DPP-4 (Gliptinas)#:**
 - Sitagliptina 100, 50 y 25 mg (*Januvia. Tesavel. Xelevia. Ristaben*®) + Metformina 1000 mg/50 mg (*Janumet. Efficib. Velmetia. Ristfor*®)
 - Vildagliptina 50 mg (*Galvus. Jalra. Xiliarx*®) + Metformina 850 y 1000 mg/50 mg (*Eucreas. Zomarist. Icandra*®)
 - Saxagliptina 5 y 2.5 mg (*Onglyza*®) + Metformina 850 y 1000 mg/2.5 mg (*Komboglyze*®)
 - Linagliptina 5 mg (*Trajenta*®) + Metformina 850 y 1000 mg/2.5 mg (*Jentaduet*®)
 - Alogliptina 25, 12.5 y 6.25 mg (*Vipidia*®) + Metformina 850 y 1000 mg/12.5 mg (*Vipdomet*®)

► SENSIBILIZADORES A LA ACCIÓN DE LA INSULINA:

- **Biguanidas:** · Metformina 850 y 1000 mg (*Dianben*®)
- **Glitazonas:** · Pioglitazona 15 y 30 mg (*Actos. Glustin*®)
 - + Metformina 850 mg/15 mg (*Competact. Glubrava*®)
 - + Glimepirida 2 y 4 mg/30 mg (*Tandemact*®)
 - + Alogliptina 12.5 y 25 mg/30 mg (*Incesync*®)

► REGULADORES DE LA REABSORCIÓN RENAL DE GLUCOSA:

- **Inhibidores SGLT-2:** · Dapagliflozina 10 mg (*Forxiga. Edistride*®) + Metformina 850 y 1000 mg/5 mg (*Xigduo. Ebymet*®)
· Empagliflozina 10 y 25 mg (*Jardiance*®) + Metformina 1000 mg/5 y 12.5 mg (*Synjardy*®)
· Canagliflozina 100 y 300 mg (*Invokana*®) + Metformina 850 y 1000 mg/50 y 150 mg (*Vokanamet*®)
· Ertugliflozina 5 y 15 mg (*Steglatro*®) + Metformina 1000 mg/2.5 y 7.5 mg (*Segluromet*®)

► RETRASAN LA ABSORCIÓN INTESTINAL DE GLUCOSA:

- **Inhibidores de α -glucosidasa:** · Acarbosa 50 y 100 mg (*Glumida. Glucobay*®)
· Miglitol 50 y 100 mg (*Plumarol. Diastabol*®)

Fuente©: **Dr. Palomares Ortega**

AGONISTAS DE GLP-1 (2021-A)©

► DIARIOS:

EXENATIDE BID:

■ Byetta®



Inicio: 5 µg/2 veces/día (1 mes)



Mantenimiento: 10 µg/2 veces/día

LIXISENATIDE:

■ Lyxumia®



Inicio: 10 µg/1 vez/día (14 días)



Mantenimiento: 20 µg/1 vez/día

LIRAGLUTIDE:

■ Victoza®



Inicio: 0.6 mg/1 vez/día (7 días)



Mantenimiento: 1.2-1.8 mg/1 vez/día

► SEMANALES:

SEMAGLUTIDE:

■ Ozempic®



Inicio: 0.25 mg/semanal (4 semanas) → 0.50 mg/semanal (≥ 4 semanas) → 1 mg/semanal (máximo)

DULAGLUTIDE:

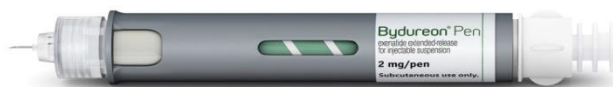
■ Trulicity®



Inicio y mantenimiento: 0.75 mg/semanal (monoterapia) o 1.5 mg/semanal (en combinación)

EXENATIDE LAR:

■ Bydureon®



Inicio y mantenimiento: 2 mg/semanal

Fuente©: Dr. Palomares Ortega

EXENATIDE BID: **Byetta®**



- ▶ **INDICACIONES:** En combinación con metformina, sulfonilureas (SU), pioglitazona, metformina + SU y metformina + pioglitazona. Coadyuvante a insulina basal con o sin metformina y/o pioglitazona.
- ▶ **MODO DE ADMINISTRACIÓN:** Administrar dentro de la hora anterior del desayuno y cena, o de las 2 comidas principales del día, separadas por ≥ 6 h.

LIXISENATIDE: **Lyxumia®**



- ▶ **INDICACIONES:** En combinación con medicamentos hipoglucemiantes orales y/o insulina basal.
- ▶ **MODO DE ADMINISTRACIÓN:** Administrar dentro de la hora anterior a la 1ª comida del día o cena.

LIRAGLUTIDE: **Victoza®**



- ▶ **INDICACIONES:** En combinación con medicamentos hipoglucemiantes orales y/o insulina basal.
- ▶ **MODO DE ADMINISTRACIÓN:** Administrar a cualquier hora del día, independiente de las comidas.

DULAGLUTIDE: **Trulicity®**



- ▶ **INDICACIONES:** En monoterapia (contraindicación ó intolerancia a metformina) y en combinación con medicamentos hipoglucemiantes incluyendo insulina.
- ▶ **MODO DE ADMINISTRACIÓN:** Administrar una vez a la **semana** a cualquier hora.

EXENATIDE LAR: **Bydureon®**



- ▶ **INDICACIONES:** En combinación con otros medicamentos hipoglucemiantes incluyendo insulina basal.
- ▶ **MODO DE ADMINISTRACIÓN:** Administrar una vez a la **semana** tras la reconstitución a cualquier hora del día.

SEMAGLUTIDE: **Ozempic®**



- ▶ **INDICACIONES:** En monoterapia (contraindicación ó intolerancia a metformina) y añadido a otros medicamentos.
- ▶ **MODO DE ADMINISTRACIÓN:** Administrar una vez a la **semana** a cualquier hora.

(Inyectar vía subcutánea en abdomen, muslo o parte superior del brazo)

INSULINAS (2021-A)©

PRANDIALES

RÁPIDAS (Humanas):

- Actrapid **InnoLet**

ULTRA-RÁPIDAS (Análogos):

- Humalog, Humalog 200 y Junior **KwikPen**
- NovoRapid **FlexPen** / **NovoPen** (PenFill)
- Apidra **SoloStar** / **JuniorStar**
- Fiasp **FlexTouch**

BASALES

INTERMEDIAS (Humanas):

- Insulatard **FlexPen**
- Humulina NPH **KwikPen**

PROLONGADAS (Análogos):

- LeveMir **FlexPen** / **InnoLet**
- Lantus **SoloStar** / **JuniorStar**
- Semglee® / Abasaglar **KwikPen**
- Toujeo **SoloStar** / **DoubleStar**
- Tresiba 100 y 200 **FlexTouch**

PRE-MEZCLAS

HUMANAS:

- Mixtard 30 **InnoLet**
- Humulina 30:70 **KwikPen**

ANÁLOGOS:

- NovoMix 30, 50 y 70 **FlexPen**
- Humalog Mix 25 y 50 **KwikPen**

DISPOSITIVOS



► **SoloStar**



► **JuniorStar**



► **Semgleé**



► **FlexPen**



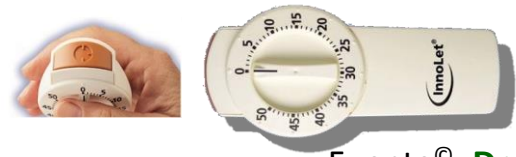
► **FlexTouch**



► **NovoPen**



► **KwikPen**



► **InnoLet**

Fuente©: **Dr. Palomares Ortega**

(En rojo, se indica el nombre de los dispositivos)

► **FLEXPEN**



NOVORAPID



NOVOMIX 30



NOVOMIX 70



INSULATARD



NOVOMIX 50



LEVEMIR

► **FLEXTOUCH**



TRESIBA



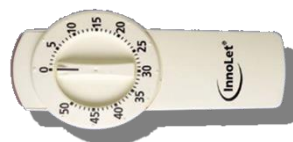
FIASP

► **NOVOPEN**



NOVORAPID PENFILL (Cartuchos)

► **INNOLET**



ACTRAPID



MIXTARD 30



LEVEMIR

► **KWIKPEN**



HUMALOG



HUMALOG 200



HUMULINA NPH



HUMULINA 30:70



HUMALOG MIX 25



HUMALOG MIX 50



ABASAGLAR



HUMALOG JUNIOR

► **SOLOSTAR**



APIDRA



LANTUS



TOUJEO



► **JUNIORSTAR**



APIDRA y LANTUS (Cartuchos)

Fuente[®]: **Dr. Palomares Ortega**

(En rojo, se indica el nombre de los dispositivos)